UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Neurologie
Hématome sous-dural chronique
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Carolina Rocha de Nobrega **Date de rédaction :** janvier 2024

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 118 – Céphalée

Domaine de compétence principal : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence secondaire : Iconographie

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA) :

1- Chercher les signes d'interrogatoire pour orienter l'enquête étiologique

2- Caractériser la douleur, le mode d'installation, le mode évolutif, et les facteurs déclenchants

3- Chercher les circonstances de survenue du traumatisme et les antécédents en précisant les troubles de l'hémostase congénital ou acquis

4- Faire le diagnostic en imagerie des pathologies cérébrales les plus fréquentes

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

1- Céphalée inhabituelle aiguë et chronique chez l'adulte et l'enfant

2- Prise en charge immédiate pré-hospitalière et à l'arrivée à l'hôpital, évaluation des complications

Patient simulé nécessaire à la station : OUI > 60/65 ans

Matériel nécessaire à la station :

- Mannequin NON

- Brancard NON
- Scanner cérébral d'hématome sous-dural (à fournir après réalisation de la tâche 2 !)

Instructions au patient simulé

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous avez 78 ans. Depuis quelques jours, vous avez des maux de tête.
Un interne en médecine générale va vous interroger puis annoncer l'examen d'imagerie indiqué. Ensuite, il interprètera cet examen.
L'IMAGERIE N'EST À FOURNIR QU'UNE FOIS QUE L'ÉTUDIANT AURA ÉNONCÉ SA NATURE !

Identité/Contexte	Nom : Hème Prénom : Estelle Âge : 78 ans Retraitée Vit à son domicile avec son mari
Antécédents	Fibrillation atriale
Médicaments actuels/ Toxiques	Warfarine Absence de toxiques
États d'esprit/ comportement	Assise. Douleur modérée Faiblement angoissée et non colérique.
Déroulement du scénario	Vous êtes assise. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *« J'ai mal à la tête depuis quelques jours. C'était d'abord léger mais ça augmente. J'ai pris un doliprane mais ça n'a rien fait, c'est pourquoi je suis venue vous voir aujourd'hui. »* Puis répondez aux questions de l'étudiant et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Depuis quand avez-vous mal ?	Cela fait 2/3 jours.
Sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous la douleur ?	Je ne sais pas, entre 5 et 7 je dirais.
La douleur est-elle apparue brutalement ?	Non, elle s'est installée progressivement et s'aggrave.
Où exactement est localisée la douleur ?	Un peu partout.
Avez-vous plus ou moins mal quand vous faites quelque chose en particulier, ou quand vous êtes dans une position particulière ?	C'est pire quand je suis allongée, et peut-être quand je fais un effort…
Avez-vous pris quelque chose pour la douleur ? Si oui, est-ce que ça a fonctionné ?	J'ai pris du doliprane mais ça n'a rien fait.
Est-ce que vous avez eu de la fièvre ou des frissons ?	Je n'ai pas mesuré ma température mais n'ai pas eu de frissons.
Avez-vous des nausées, des vomissements, une phobie de la lumière ou du bruit, des troubles de la vision, ou d'autres symptômes associés ?	J'ai beaucoup vomi hier matin. Maintenant que je vous en parle, la douleur a alors diminué mais a réaugmenté rapidement.
Avez-vous des antécédents médicaux ou chirurgicaux à me signaler ?	J'ai une fibrillation atriale. Je n'ai jamais été opérée.
Prenez-vous des traitements ?	Le traitement de la fibrillation atriale, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Un anticoagulant ?	Oui c'est ça !
Avez-vous chuté récemment ?	Euh… Oui, je me souviens, j'ai trébuché dans les escaliers chez moi il y a un peu plus d'un mois, mais tout allait bien après.
Quand vous êtes tombée, avez-vous tapé la tête ?	Je ne me souviens plus, peut-être.
Avez-vous perdu du poids, l'appétit ? Vous sentez-vous plus fatiguée que d'habitude ?	Non, non, tout va bien.
Est-ce que vous avez déjà eu une douleur semblable ?	Non, jamais.

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en médecine générale et recevez au cabinet Madame Hème, 78 ans, se présentant pour des céphalées.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser un interrogatoire ciblé sur ses céphalées
2. Annoncer l'examen d'imagerie indiqué
3. Décrire l'examen d'imagerie prescrit

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Recherche les caractéristiques de la douleur (≥ 3 parmi : intensité, mode d'installation, mode évolutif, localisation, facteurs calmants et/ou aggravants, antériorité)	
Recherche l'existence d'antécédents médicaux et chirurgicaux	
Recherche un traumatisme crânien	
Recherche la prise d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires	
Recherche la présence de signes de localisation	
Recherche la présence de nausées et/ou vomissements	
Recherche la présence d'un syndrome infectieux	
Recherche la présence d'une altération de l'état général (≥ 2 parmi amaigrissement/perte de poids, perte d'appétit, fatigue)	
Tâche 2	
Demande un scanner cérébral non injecté	
Tâche 3	
Reconnaît un scanner cérébral	
Reconnaît le caractère non injecté de l'examen	
Reconnaît le plan d'acquisition axial	
Caractérise la lésion : forme de « croissant de lune » concave en dedans et convexe vers l'extérieur, côté droit, hypodensité	
Précise, qu'en dehors de la lésion, l'examen est sans anomalie	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à écouter	1 à 5
Aptitude à questionner	
Aptitude à structurer/mener l'entrevue	
Communication non verbale	
Aptitude à faire la synthèse des données	

L'IMAGERIE N'EST À FOURNIR QU'UNE FOIS QUE L'ÉTUDIANT AURA ÉNONCÉ SA NATURE !

TUT'ECOS

Aptitude à écouter :

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

Aptitude à questionner :

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

Aptitude à structurer/mener l'entrevue :

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

Communication non verbale :

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

Aptitude à faire la synthèse des données :

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tâche 1	
Recherche les caractéristiques de la douleur (≥ 3 parmi : intensité, mode d'installation, mode évolutif, localisation, facteurs calmants et/ou aggravants, antériorité)	1
Recherche l'existence d'antécédents médicaux et chirurgicaux	1
Recherche un traumatisme crânien	1
Recherche la prise d'anticoagulants ou d'antiagrégants plaquettaires	1
Recherche la présence de signes de localisation	1
Recherche la présence de nausées et/ou vomissements	1
Recherche la présence d'un syndrome infectieux	1
Recherche la présence d'une altération de l'état général (≥ 2 parmi amaigrissement/perte de poids, perte d'appétit, fatigue)	1
Tâche 2	
Demande un scanner cérébral non injecté	1
Tâche 3	
Reconnaît un scanner cérébral	1
Reconnaît le caractère non injecté de l'examen	1
Reconnaît le plan d'acquisition axial	1
Caractérise la lésion : forme de « croissant de lune » concave en dedans et convexe vers l'extérieur, côté droit et en hypodensité	1
Précise, qu'en dehors de la lésion, l'examen est sans anomalie	1
	/14
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à écouter	Échelle de 1 à 5
Aptitude à questionner	
Aptitude à structurer/mener l'entrevue	
Communication non verbale	
Aptitude à faire la synthèse des données	
NOTE TOTALE	**/19**